Gobierno de México | Ciencia y Tecnología, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación | UNRC Universidad Nacional Rosario Castellanos

LA ECONOMÍA DEL CUIDADO

AVANCE 1°

EL TEMA, LO QUE ENCONTRAMOS EN LOS DATOS Y LO QUE PROPONEMOS

CIENCIAS DE DATOS PARA NEGOCIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS
7° SEMESTRE



OMAR GUTIÉRREZ ESCOTO
DANIEL CUREÑO MARTÍNEZ
ALONDRA DANAE MADRIGAL GARCÍA

SECCIÓN 1

El tema: la economía del cuidado

La economía del cuidado es el trabajo que sostiene la vida diaria de quienes no pueden valerse por sí mismos. Casi todo ocurre dentro de los hogares, sin pago y sin registro. La idea que resume el punto de partida es simple: **cuidar es masivo; pagar por cuidado es excepcional.**

Indicador	Valor
Personas de 15 años o más que cuidan a alguien	32.0 % (31.7 millones)
Personas de 15 a 60 años que serían cuidadoras si les pagaran	40 % (45 % entre las mujeres)
Hogares con personas mayores o con discapacidad que contratan cuidado	≈ 1 %

Fuente: ENASIC 2022 (INEGI), microdatos · notebook 03.

SECCIÓN 2

Planteamiento y pregunta de investigación

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Dónde está el hueco entre la necesidad de cuidado y lo que se ofrece?

- **A quién:** personas mayores y personas con discapacidad que dependen de otras, y quienes las cuidan.
- **Dónde:** la Ciudad de México por alcaldía para la oferta; el país para la carga de cuidado.
- **Para qué:** un Observatorio que lo mida y un programa de innovación social derivado de lo que encuentre.

SECCIÓN 3

Marco de análisis: las 3R del cuidado

La política de cuidados suele organizarse con el marco de las "3R", formulado por la economista Diane Elson: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado (Elson, 2017). La Organización Internacional del Trabajo lo amplió a "5R" al agregar recompensar y representar a quienes cuidan de forma remunerada (OIT, 2018).

R	Qué significa	Pregunta que le hace al proyecto
Reconocer	Hacer visible el trabajo de cuidados: medirlo, contarlo y valorarlo como trabajo.	¿Quién cuida, cuánto y con qué costo para su salud y su empleo?
Reducir	Disminuir la carga de cuidado de los hogares, sobre todo la más pesada, con servicios e infraestructura.	¿Qué servicio reduce la carga de quien más cuida, y en qué formato lo acepta?
Redistribuir	Repartir el cuidado de forma más equitativa: entre mujeres y hombres, y entre hogares, Estado, mercado y comunidad.	¿Se puede repartir dentro del hogar, o solo hacia afuera?
Recompensar (5R)	Pagar de forma justa y con seguridad social a quienes cuidan por un salario.	¿Cuánto se paga hoy y cuánto costaría pagar el piso legal?
Representar (5R)	Dar voz y organización a las personas cuidadoras en las decisiones que las afectan.	Sin datos en el proyecto: queda fuera del alcance.

3.1 Las 3R en la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México usa una variante del marco "revalorar, redistribuir y reducir" para nombrar sus Casas de las 3R. La primera abrió el 21 de mayo de 2025 y el plan es construir 200 en seis años (El Financiero, 21 de mayo de 2025). Ofrecen, en un mismo edificio, cuidado infantil, lavandería gratuita, comedor comunitario, cuidado de día para personas mayores y servicios para personas con discapacidad. El presupuesto 2026 solicitado para ellas es de 568 millones de pesos.

PARA EL PROYECTO

Las Casas de las 3R, como el SIDECU, son servicios de establecimiento. El cuidado en casa, que es la modalidad que prefiere el 58 % (hallazgo 2), no tiene una línea propia. Ese es el hueco donde se ubica el programa.

NIVEL DE EVIDENCIA

568 millones: Proviene de la solicitud reportada en prensa y está pendiente de contrastar con el decreto aprobado. Expansión Política (25 de diciembre de 2025) reporta 400 millones de pesos para la instalación de nuevas Casas de las 3R en 2026; las dos cifras no coinciden y pueden referirse a conceptos distintos.

Elson: la cita localizable es Elson (2017), *New Labor Forum*; una versión previa decía 2008 (corregido el 24 de septiembre de 2026 tras verificarlo vía CIEP).

SECCIÓN 4

Nichos de la economía del cuidado

La "Economía del cuidado" nombra un campo demasiado amplio para un Observatorio de un semestre. Por eso se distinguieron sus nichos y se eligió uno con criterios explícitos. Un nicho se define por **quién recibe el cuidado** y **qué tipo de cuidado es**, porque esa combinación determina qué datos existen y qué intervención es posible.

4.1 Cuáles son

Nicho	Quién recibe el cuidado	Qué se necesita medir
N1 · Primera infancia	Niñas y niños de 0 a 5 años	Cobertura de estancias y CENDI, jornada laboral de madres y padres, distancia al servicio
N2 · Edad escolar	Niñas y niños de 6 a 14 años	Horas de acompañamiento escolar, desfase entre horario escolar y laboral
N3 · Personas mayores dependientes	Personas de 60 y más con limitación funcional	Dependencia en actividades de la vida diaria, oferta residencial y domiciliaria, costo

Nicho	Quién recibe el cuidado	Qué se necesita medir
N4 · Personas con discapacidad	Todas las edades, con discapacidad	Tipo y grado de apoyo requerido, servicios especializados disponibles
N5 · Enfermedad crónica o recuperación	Personas en tratamiento o convalecencia	Episodios, duración, articulación con el sistema de salud
N6 · Respiro para quien cuida	Personas cuidadoras no remuneradas	Carga horaria, desgaste, renuncia al empleo, salud de la persona cuidadora
N7 · Trabajo del hogar remunerado	Personas trabajadoras del hogar	Salario, formalidad, seguridad social, condiciones de trabajo
N8 · Formación y certificación	Personas que cuidan, pagadas o no	Oferta formativa, certificación, brecha de competencias

4.2 Criterios de selección

Se eligió por lo que los datos permiten afirmar, no por lo que resulta atractivo. Cada nicho se calificó con 0, 1 o 2 en seis criterios:

- **C1** · microdatos públicos y reproducibles disponibles.
- **C2** · posibilidad de desagregar por alcaldía o menos.
- **C3** · necesidad declarada medida, no solo inferida de la demografía.
- **C4** · oferta instalada medida o localizable.
- **C5** · hueco de política pública documentado: que el nicho no esté ya cubierto por un programa.
- **C6** · posibilidad de levantar dato propio en el piloto de práctica profesional.

4.3 Matriz de decisión

Nicho	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total	%
N1 · Primera infancia	2	1	2	2	0	1	8 / 12	67 %
N2 · Edad escolar	1	1	1	0	1	1	5 / 12	42 %
N3 · Personas mayores dependientes	2	1	2	2	2	2	11 / 12	92 %
N4 · Personas con discapacidad	2	2	2	1	2	2	11 / 12	92 %
N5 · Enfermedad crónica o recuperación *	2	0	1	1	1	1	6 / 12	50 %
N6 · Respiro para quien cuida *	2	0	2	1	2	2	9 / 12	75 %
N7 · Trabajo del hogar remunerado *	2	0	NA	NA	1	1	4 / 8	50 %
N8 · Formación y certificación	1	0	2	1	1	1	6 / 12	50 %

Escala: 0 = no cumple, 1 = cumple en parte, 2 = cumple, NA = el criterio no corresponde al nicho o no es el área que el Observatorio procesa. Como NA reduce el máximo posible, los nichos se comparan por porcentaje. * Calificación corregida el 24 de septiembre de 2026 (Anexo A). Base: Documento integrado v0.2, sección 4.3.

Las calificaciones que más pesan en el resultado:

- **N3 y N4 tienen 2 en C1** porque el equipo procesó los microdatos de la ENASIC con su diseño muestral y reprodujo cifras publicadas por el INEGI.
- **N1 tiene 0 en C5** porque en noviembre de 2024 el Gobierno de la CDMX anunció la construcción de 300 Centros de Desarrollo Infantil (Expansión Política, 15 de noviembre de 2024); la meta de 200 Casas de las 3R proviene de otra fuente (El Financiero, 21 de mayo de 2025). La Ley del Sistema Público de Cuidados de la CDMX, promulgada el 2 de julio de 2026, incluye 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil

en su plan de infraestructura (La Silla Rota, 2 de julio de 2026); no se ha confirmado si lo establece como obligación legal. La cifra de 920.1 millones para primera infancia de una versión previa no se localizó en ninguna fuente.

- **N4 tiene 2 en C2** porque existe población con discapacidad por AGEB (Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México) y el equipo tiene el archivo por alcaldía.
- **N5, N6 y N7 tienen 0 en C2** porque ninguna fuente de sus poblaciones (ENASIC, ENSANUT, ENOE) es representativa por alcaldía.

4.4 Nicho elegido

> **NICHO DE TRABAJO**
> Cuidado de personas mayores con dependencia funcional y de personas con discapacidad, con énfasis en la modalidad domiciliaria, en la Ciudad de México (N3 + N4).

Se trabajan juntos porque la fuente principal los trata juntos: la ENASIC define el universo de hogares con necesidad como los que tienen una persona con discapacidad o de 60 años y más. Las razones de la elección:

- **Necesidad declarada medida:** si se buscó un servicio, por qué no, dónde se preferiría el cuidado y a qué precio se contrata.
- **Modalidad preferida clara:** 58 % querría el cuidado en casa y menos del 5 % en una institución.
- **Hueco de política documentado:** ni el SIDECU ni las Casas de las 3R tienen una línea de cuidado domiciliario.
- **Dato propio en el piloto:** permite levantar por qué un hogar concreto no contrata cuidado en casa.

4.5 Qué queda fuera

Dejar un nicho fuera significa que el Observatorio no podrá afirmar nada propio sobre él: ni sobre cuidado infantil, ni sobre la carga de las personas cuidadoras a nivel territorial, ni sobre las condiciones del trabajo del hogar en la CDMX. Cualquier mención a esos temas será cita de otra fuente.

SECCIÓN 5

Fuentes de datos

Se trabajó con cuatro fuentes; cada una tiene un límite que condiciona lo que se puede afirmar.

Fuente	Escala	Permite	No permite
ENASIC 2022	Nacional	Saber quién cuida, cuánto, qué necesita y por qué no busca ayuda	Conclusiones por alcaldía ni tendencias: es la primera edición
DENUE 05_2026	CDMX	Contar establecimientos de cuidado por alcaldía	Conocer su capacidad, horario o personal
Censo y CSV de capacidad	CDMX	Población 60+ y plazas residenciales por alcaldía	Fechar ni atribuir con certeza dos de los archivos
Anexo 31 y SIDECU	Federal	Gasto público y directorio nacional de centros	Medir el cuidado en casa, que no tiene establecimiento

La ENASIC se analizó con factores de expansión, estratos (EST_DIS) y conglomerados (UPM_DIS); cada estimación lleva su precisión según el coeficiente de variación del INEGI: **alta** por debajo de 15 %, **moderada** de 15 a 30 %, **baja** desde 30 %.

SECCIÓN 6

Hallazgos

Hallazgo 1. Casi nadie busca servicios, y no por falta de información

Solo **3.0 %** de las personas cuidadoras buscó servicios de cuidado (precisión alta), y apenas **0.9 %** no lo hizo porque no sabe que existen (precisión moderada). Entre quienes cuidan a una persona mayor o con discapacidad y no buscaron, la mayoría dice que no tuvo necesidad o que el propio hogar cuida.

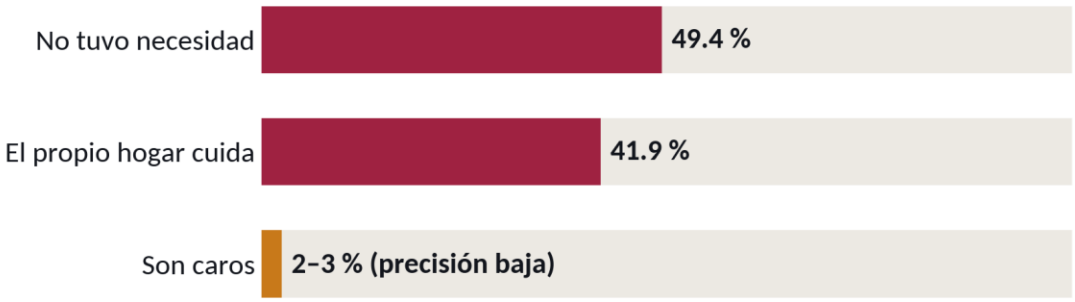


Figura 1. Razones para no buscar servicios de cuidado, entre quienes no buscaron. «Son caros» tiene precisión baja y se muestra como rango. Fuente: microdatos ENASIC 2022, notebooks 03 y 07.

LECTURA

Si la barrera fuera la información, desconocer los servicios pesaría mucho más que 0.9 %. Un buscador de servicios no resuelve el problema medido. Nota: 3.0 % y 0.9 % se calculan sobre todas las personas cuidadoras; la figura, sobre quienes no buscaron.

Hallazgo 2. Lo que se pide es apoyo en casa, no residencias

La necesidad declarada es de enfermería o de una persona cuidadora, no de una residencia. Además, **58 %** preferiría el cuidado en casa si contratara, y menos del **5 %** en una institución.

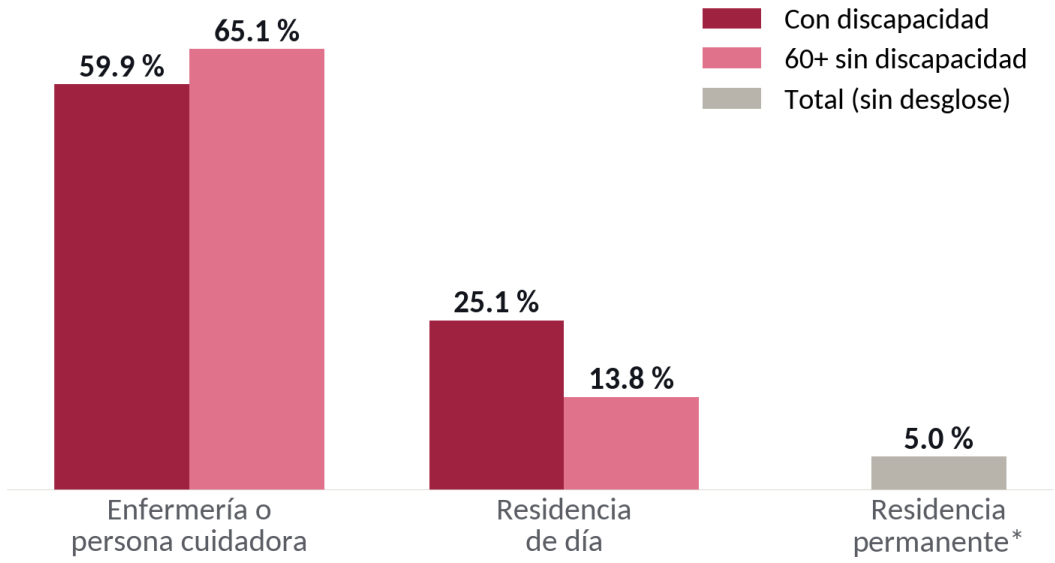


Figura 2. Tipo de apoyo que se necesita. *Residencia permanente: 5.0 % en total, sin desglose por grupo. Fuente: ENASIC 2022, presentación de resultados del INEGI (25 feb 2025); notebook 03.

CONSECUENCIA

Un faltante de plazas residenciales (hallazgo 6) no basta para justificar abrir residencias.

Hallazgo 3. La carga que no se nombra

Decir «no tuve necesidad» casi no cambia con la intensidad del cuidado, pero el daño declarado sí: con 40 horas o más a la semana, **70.5 %** declara algún daño a su salud o a su trabajo, frente a **42.6 %** con menos de 20 horas. La salud física deteriorada pasa de 9.3 % a 31.4 %.

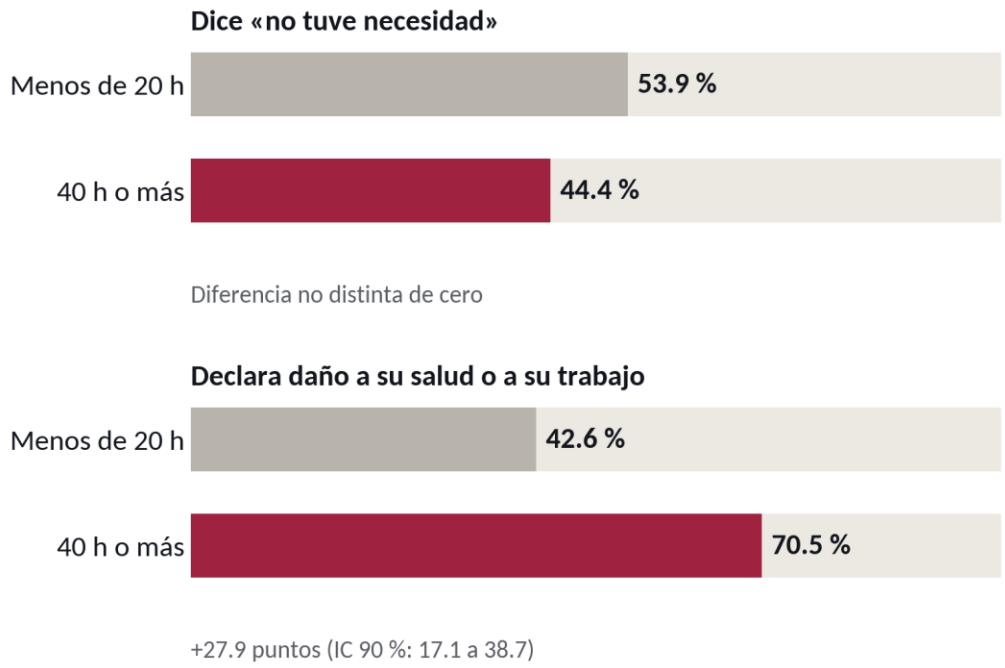


Figura 3. Necesidad y daño declarados según horas de cuidado a la semana. Fuente: Analysis/07_enasic_necesidad_vs_norma.ipynb, factor FAC_CUI.

HALLAZGO CENTRAL · GRUPO DEL PROBLEMA

12.5 % de quienes cuidan dedica 40 horas o más, dice «no tuve necesidad» y declara daño: unas 0.78 millones de personas en el país. Es una asociación en una encuesta transversal, no una relación causal: quienes cuidan más horas pueden diferir en edad, ingreso o en la dependencia de la persona que cuidan.

Hallazgo 4. La norma familiar domina, pero deja una puerta

La familia se asume como responsable del cuidado, pero **una de cada tres** personas acepta apoyo «solo unas horas al día». De quienes rechazan una residencia, **25.3 %** dice que «tratan mal a las personas»; quienes aceptarían una institución piden, en ese orden, personal capacitado, buen trato y precio.

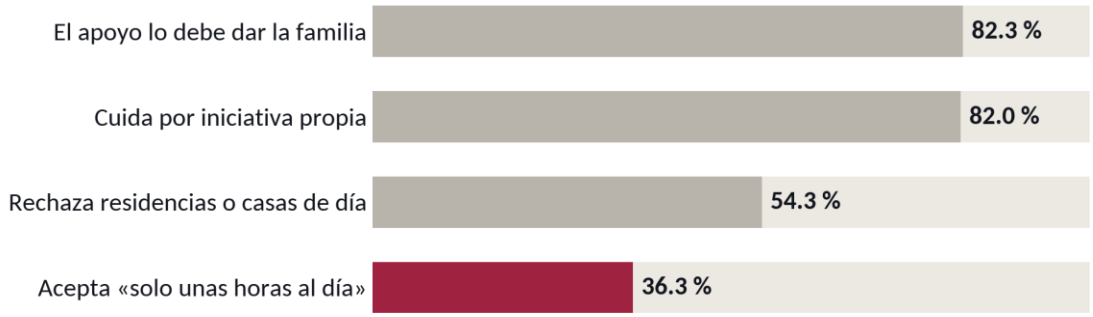


Figura 4. Opiniones sobre quién debe cuidar. Fuente: ENASIC 2022, preguntas P7.7, P6.38 y P7.8; notebook 07.

LECTURA

El relevo por horas encaja con la norma familiar en lugar de competir con ella. Que la norma sea fuerte no demuestra que sea la causa de que no se contrate; es la explicación con más respaldo directo.

Hallazgo 5. Los hogares que sí pueden pagar contratan limpieza, no cuidado

Del quintil de ingreso más bajo al más alto, contratar trabajo doméstico se multiplica por **7.6** y contratar cuidado solo por **2.7**. El precio no parece ser la razón principal que se declara para no contratar.

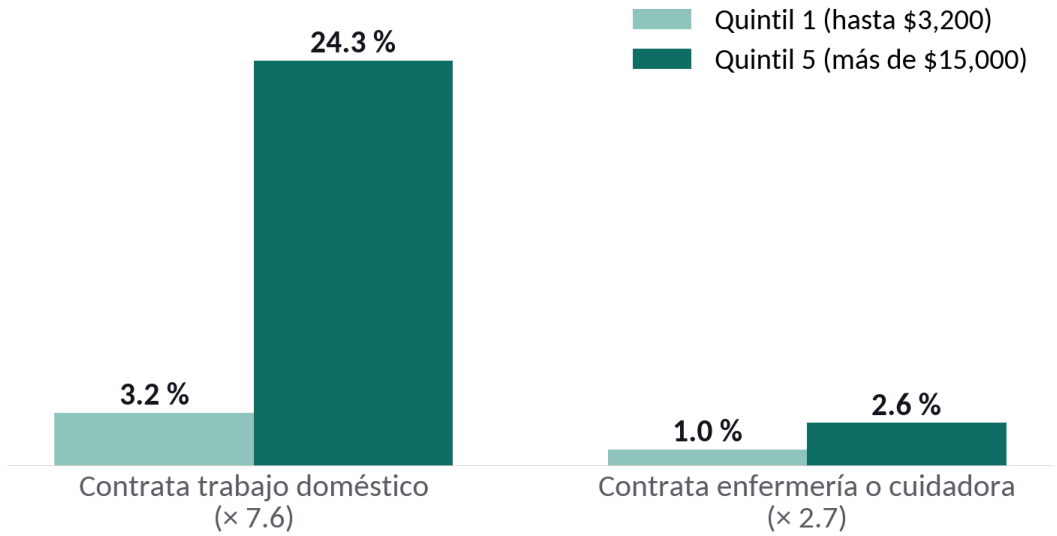


Figura 5. Contratación por quintil de ingreso. La razón de cuidado es 2.61/0.96 = 2.7 (corregido el 24 de septiembre de 2026; antes 2.6). Quintil alto con pocos casos. Fuente: ENASIC 2022; script 04.

Hallazgo 6. En el oriente de la ciudad faltan plazas, pero la demanda no es de plazas

Iztapalapa concentra cerca del **18 %** de la población de 60 años o más de la CDMX y menos del **1 %** de las plazas residenciales privadas. Iztacalco, Iztapalapa y Gustavo A. Madero tienen menos de la mitad de las plazas que les tocarían por su población, con tres formas distintas de medir la necesidad.



Figura 6. Iztapalapa: su peso en la ciudad (17.6 % de la población de 60+ y 0.9 % de las plazas, recalculado sobre los CSV). Fuente: CSV de capacidad y de población 60+; notebooks 01 y 02.

Además, la correlación entre número de asilos y número de plazas por alcaldía es de **0.27** (Spearman, n = 12): no hay una relación clara entre contar establecimientos y medir capacidad.

NIVEL: PROBABLE

El CSV de capacidad no documenta productor ni año (origen probable: SINGE, SEMUJERES CDMX; ver sección 5), y no se sabe si cuatro alcaldías valen cero o son dato faltante. Con n = 12, una correlación de 0.27 no es distinguible de cero.

Hallazgo 7. Casi la mitad de los «centros de día» registrados son espacios recreativos

De **126** centros de día para personas mayores en el DENUE, **59** se llaman club, grupo o casa del adulto mayor: la clasificación económica no distingue cuidado de recreación, así que contar centros sobrestima la oferta. En el núcleo de cuidado, 49 de 235 establecimientos tienen un nombre que no indica cuidado y esperan revisión manual.

Esos espacios ya existen y podrían alojar relevo por horas, pero hoy se desconoce su capacidad, horario y personal. El SIDECU y el Mapa de Cuidados podrían aportarlos.

Fuente: DENUE 05_2026 CDMX; Analysis/01_denue_oferta_cuidado.ipynb.

Hallazgo 8. El gasto federal en cuidados ya existe y se concentra en transferencias

Indicador	Valor
Anexo Transversal 31, PPEF 2026	466,675 millones de pesos (1.2 % del PIB)
Pensiones del Bienestar dentro del anexo	166,136 millones (36 %)
Centros públicos en SIDECU	≈ 118,618
Secretaría de las Mujeres	2,140 millones (< 0.5 % del anexo)

El anexo no es dinero nuevo: reclasifica 47 programas que ya existían, de 19 dependencias según Fundar. El SIDECU ya funciona como directorio nacional de centros, pero sus cinco categorías son establecimientos: el cuidado en casa no aparece.

Fuentes: cuidados.mujeres.gob.mx (consulta 23 sept 2026); Fundar (2025); CIEP (2025). CIEP reporta que la Pensión para Adultos Mayores equivale a 26.4 % del anexo; la diferencia con el 36 % de Fundar se debe a que Fundar suma todas las Pensiones del Bienestar.

SECCIÓN 7

Síntesis: lo que cambió

Creíamos	Encontramos
Las familias no encuentran servicios de cuidado.	Quien cuida mucho no nombra su carga como necesidad; la familia se asume responsable, pero acepta apoyo por horas si hay confianza.

Por eso el problema se replantea como uno de tres cosas:

- **Detección:** la cuidadora no busca; hay que encontrarla (hallazgos 1 y 3).
- **Formato:** horas de relevo, no residencias (hallazgos 2 y 4).
- **Confianza:** personal capacitado y buen trato antes que precio (hallazgos 4 y 5).

SECCIÓN 8

Propuesta de programa

Relevo por horas para la persona cuidadora de alta intensidad, en tres pasos:

Paso	Qué hace	Hallazgo que lo sostiene
1. Detectar	Encontrar a la cuidadora desde una institución (salud, DIF, escuela) con tres preguntas: horas semanales, si ayuda en actividades básicas y si declara daño.	1 y 3: no busca servicios
2. Relevar	Ofrecer unas horas de cuidado a la semana como complemento de la familia, en casa o en espacios que ya existen.	2, 4 y 7: se acepta el apoyo por horas

Paso	Qué hace	Hallazgo que lo sostiene
3. Garantizar calidad	Cuidadoras con certificación CONOCER y un estándar de trato comprobable. Que la certificación esté presupuestada en el Anexo 31 está por verificar.	4: se pide personal capacitado y buen trato

GRUPO OBJETIVO

Unas 0.78 millones de personas en el país (12.5 % de quienes cuidan).

8.1 El programa frente a las 3R

R	Qué dicen los datos	Qué hace el programa	Qué falta
Reconocer	La carga intensa no se nombra como necesidad, pero deja daño (hallazgo 3).	Detecta a la cuidadora desde una institución y registra su carga.	Una pregunta que separe «no necesito un lugar» de «no necesito apoyo».
Reducir	Se acepta apoyo por horas, no residencias (hallazgos 2 y 4).	Relevo por horas en casa o en espacios existentes.	Capacidad real de los centros de día y de las Casas de las 3R.
Redistribuir	La familia se asume responsable; 82.3 % dice que el apoyo debe darlo la familia.	Relevo externo como complemento de la familia, no como sustituto.	Medir si hay adultos en el hogar que no cuidan.
Recompensar	Cerca de la mitad de los arreglos pagados está al nivel del salario mínimo profesional o por debajo.	Pago al piso legal y certificación CONOCER.	Quién paga: el costo no cabe en el presupuesto de la ciudad.

SECCIÓN 9

La plataforma

El problema prototípico exige dos perfiles funcionales y un modelo de emparejamiento. Cada perfil se sostiene en un hallazgo:

Perfil	Cómo funciona	Base en los datos
«Necesito cuidado»	Entra por la detección institucional, no por una búsqueda; pide horas de relevo, no un lugar; ve la certificación y el historial de trato de quien la atiende.	Hallazgos 1 a 4
«Puedo cuidar»	Se registra, se certifica y declara sus horarios.	40 % cuidaría si le pagaran y 95 % de ellas se capacitaría; 68.4 % de las cuidadoras que quieren trabajar no tiene quién cuide por ellas

El emparejamiento cruza horas requeridas con cuidadoras certificadas y cercanas. No es un directorio: ese ya existe a escala nacional (SIDECU). La oferta latente es intención declarada; el piloto debe medir cuánta se convierte en disposición real.

SECCIÓN 10

Costo y escala

Escenario: subsidiar media jornada de cuidado al 25 % de los hogares con necesidad cuesta **$936 por hogar al mes**.

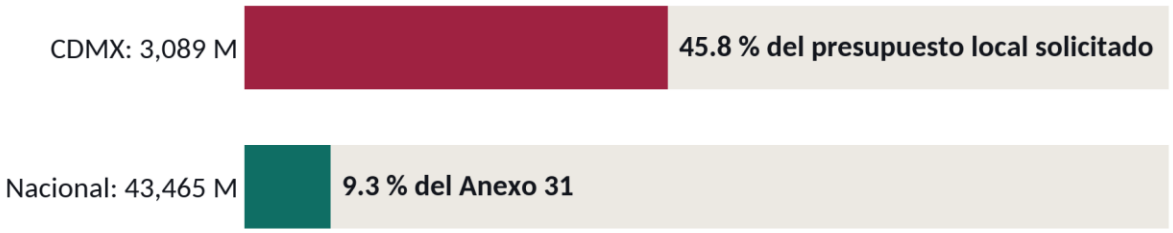


Figura 7. Costo anual del subsidio frente al presupuesto de referencia. Fuente: script 06; Anexo 31, PPEF 2026; presupuesto de cuidados solicitado por la CDMX (6,748 millones, fuente original por verificar).

CONCLUSIÓN

Un subsidio amplio no cabe en el presupuesto de la ciudad. Si hay subsidio, se focaliza en el grupo de alta intensidad y se discute a escala federal. Es un escenario de costo, no una estimación de impacto; el interlocutor del programa sigue sin decidirse.

SECCIÓN 11

Riesgos legales y gobernanza del cuidado

Trabajamos con personas mayores y personas en situación de dependencia, una población que el propio planteamiento institucional ya identifica como vulnerable. El documento de riesgos que Daniel preparó el 18 de septiembre justificaba la verificación de personas cuidadoras citando 863 casos de maltrato a personas mayores en la CDMX (2020); en nuestra revisión del 20 de septiembre ya habíamos señalado que esa violencia registrada es mayoritariamente familiar, así que no sostenía por sí sola el riesgo de terceros que se usaba para justificar la plataforma.

A partir de una pregunta sobre la película *I Care a Lot* —donde un tercero profesional se apodera del patrimonio de una persona mayor explotando el sistema de tutela legal— investigamos cuatro preguntas: qué tipos de fraude y abuso existen en el entorno del cuidado a personas mayores en México, quién los comete típicamente, si la interdicción/tutela es explotable en México como en la película, y qué implica esto para el diseño de la plataforma y del protocolo de gobernanza de datos.

11.1 Cuatro categorías de riesgo que no promediamos

«Fraude en el cuidado» no es una sola categoría. Agrupar los cuatro fenómenos bajo una sola cifra produce conclusiones equivocadas sobre quién es la amenaza real para la plataforma.

Categoría	Quién lo comete típicamente
1. Abuso / control patrimonial cotidiano	Familiar o persona cuidadora cercana
2. Estafa dirigida (p. ej. «pensionazo»)	Tercero desconocido
3. Fraude institucional en programas de cuidado subsidiados	Operador del programa con incentivo económico
4. Interdicción/tutela explotada por un tercero profesional	Tercero profesional

11.2 Abuso patrimonial cotidiano: el riesgo mejor documentado, y es familiar

En la CDMX, el Consejo Ciudadano registró **7,821** atenciones por maltrato a personas mayores entre enero de 2019 y julio de 2023 (66 % contra mujeres, 34 % contra hombres; el maltrato psicológico es el más frecuente, con 28.1 %). La nota que reporta esta cifra señala que «la mayor parte de las veces son familiares los victimarios» (La Silla Rota, 11 de enero de 2024).

La cifra que circula de que 97 % del maltrato proviene de familiares no tiene, hasta donde pudimos rastrear, un estudio primario con metodología publicada: se atribuye a un vocero. La dejamos como **probable**.

El estudio con metodología más sólida que localizamos es de la Keck School of Medicine (USC): unas 2,000 llamadas al National Center on Elder Abuse de Estados Unidos (2014–2017). Cerca de 48 % de las llamadas con relación identificada involucraban a familiares, y 61.8 % del abuso cometido por familiares fue financiero. Limitación declarada: sesgo de selección.

11.3 Estafas dirigidas por terceros: un fenómeno activo y distinto

La modalidad activa en 2026 es el **«pensionazo»**: defraudadores que se hacen pasar por gestores de pensiones del IMSS, contactan por redes sociales (33 % Facebook) o por teléfono (24 %) y logran transferencias de $4,000 a $70,000 pesos; 81 % de las víctimas paga bajo el pretexto de un trámite. El 21 % de los reportes de actividad delictiva contra personas mayores ya ocurre en línea, según el Consejo Ciudadano, que reporta 111,182 atenciones a personas mayores en seis años.

Esta categoría sí corresponde al tipo de amenaza que una plataforma con terceros (perfil «Puedo cuidar») necesita mitigar.

11.4 Fraude institucional en programas subsidiados: un paralelo

En 2019 se documentó que el programa de Estancias Infantiles reportaba más de 80,000 “niños fantasmas”. De 9,582 estancias supervisadas, 40 % presentaba riesgo total y solo 30 % cumplía los estándares; se detectaron traslapes con derechohabiencia IMSS/ISSSTE (27,242 y 77,000 casos) y beneficios duplicados con Prospera (Forbes México; Expansión Política).

Lo incluimos como **paralelo estructural, no como evidencia sobre personas mayores**: cuando un programa subsidiado no verifica a sus operadores, el fraude lo comete un tercero dentro del sistema.

11.5 Implicaciones para el diseño

- **Verificación de identidad en «Puedo cuidar»:** se sostiene con la evidencia de la categoría 2, no con la cifra de maltrato familiar.
- **Gobernanza de datos:** si el programa opera con financiamiento público, la categoría 3 obliga a auditar padrón y operadores, no solo a proteger datos personales.
- **Tutela/interdicción:** sin evidencia en México, no diseñamos mecanismos específicos; queda como pregunta abierta.
- El reencuadre alrededor de la norma familiar y el precio (decisión del 20 de septiembre, matizada el 23) sigue siendo el eje del programa; esta investigación aporta el marco de riesgo que faltaba.

SECCIÓN 12

El segmento en la Ciudad de México

NOTA DE VERSIÓN · 2 DE OCTUBRE DE 2026

Las secciones 12 a 18 se agregaron a este avance a partir del Documento Maestro de avance (25 de septiembre de 2026). Cada cifra se volvió a comprobar contra los archivos de resultados del proyecto (Analysis/resultados). Hubo dos correcciones respecto al Documento Maestro, señaladas donde ocurren: la tabla de paquetes de la sección 14 y la conversión a hogares del 35.9 % de esta sección. Ninguna de estas secciones tiene todavía doble revisión.

La ENASIC es nacional y no admite estimaciones para la Ciudad de México. Por eso se calcularon tasas nacionales con la encuesta y se aplicaron a las 2,756,319 viviendas particulares habitadas de la ciudad que reporta el Censo 2020. El resultado es una inferencia con un sesgo de dirección conocida: la Ciudad de México está más envejecida que el promedio nacional, así que la cifra de hogares con necesidad es una **cota inferior**, no una estimación central.

Nivel	Hogares	Cómo se obtuvo
Hogares con una persona con discapacidad o de 60 años y más	1,099,461	Tasa nacional (39.9 %) × viviendas del Censo 2020
De ellos, pagan trabajo doméstico	86,193	Tasa nacional de contratación (7.8 %)
De ellos, pagan enfermería o cuidadora	11,300	Tasa nacional de contratación (1.0 %)

Fuente: ENASIC 2022 [1]; Censo 2020 [4] · script 05 [58].

El dato que ordena la estrategia comercial es la relación entre los dos grupos pequeños: por cada hogar que paga cuidado hay **7.6 que ya pagan trabajo doméstico**. Ahí está el segmento de entrada: hogares que ya tienen capacidad de pago y ya aceptan que alguien ajeno entre a su casa, pero no han delegado el cuidado de la persona.

NIVEL DE EVIDENCIA · PROBABLE

Las tres cifras resultan de aplicar tasas nacionales a conteos de la ciudad; la de cuidado, además, es una doble inferencia. Sirven para dimensionar, no deben citarse como dato duro de la CDMX.

Hay un límite que ningún diseño de producto mueve: el **35.9 %** de quienes cuidan a una persona con discapacidad o de 60 y más declara que no contrataría a nadie (ENASIC 2022, coeficiente de variación de 7.3 %). Es el tamaño del problema que este tipo de programa no resuelve.

CORRECCIÓN · UNIDAD DE MEDIDA

El Documento Maestro convertía este 35.9 % en «unos 394,706 hogares» de la CDMX. No se reporta aquí: la tasa es de *personas cuidadoras* y la cota de 1,099,461 es de *hogares*, así que multiplicarlas mezcla unidades.

12.1 Hallazgo 9. La pobreza baja con la edad, pero no mide necesidad de cuidado

Con el archivo de CONEVAL de pobreza por grupos poblacionales a escala municipal, la pobreza en las 16 alcaldías baja de forma monótona con la edad en 2020.

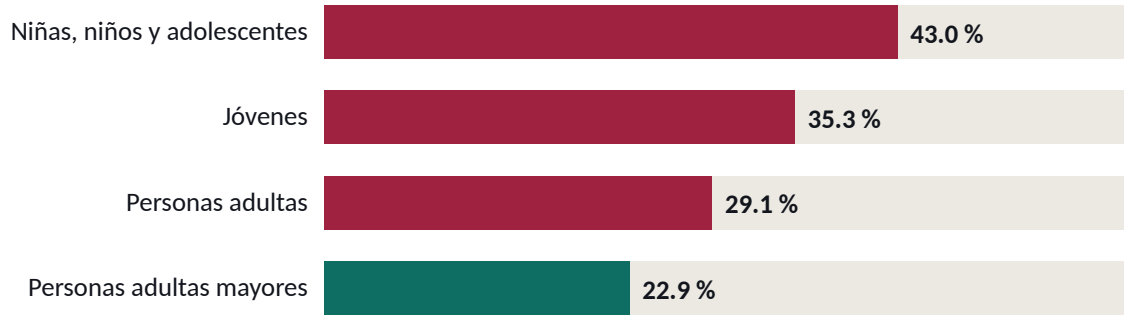


Figura 8. Porcentaje de población en pobreza por grupo de edad, CDMX, 2020. Promedio simple de las 16 alcaldías, no ponderado por población. Fuente: CONEVAL [13] · notebook 09 [58].

Qué no dice esto: no es un indicador de necesidad de cuidado ni cambia el nicho elegido (N3 y N4). Es contexto de vulnerabilidad económica. Nivel: probable, con un solo corte (2020) y sin doble revisión.

También se revisó el Observatorio de Cuidados de INMUJERES, que declara 374 indicadores [57]. No se cita como hallazgo: no se localizó la metodología de su «tasa de demanda potencial», sus

indicadores de establecimientos usan el mismo DENUE con los problemas del hallazgo 7, y sus cifras de pobreza son las de CONEVAL, que se obtuvieron directo del productor. Queda como fuente candidata, pendiente de ficha.

SECCIÓN 13

Qué dice el mercado: doce referencias

Se construyó una matriz de 12 casos en México, Estados Unidos y Europa. Se incluyeron a propósito dos empresas que cerraron, para no aprender solo de las que sobrevivieron. Salen cuatro patrones:

- **Cobrar solo a la familia es un riesgo, no una sentencia.** Los dos cierres (HomeHero y Respect) cobraban a la familia, y dos sobrevivientes que también lo hacían (Cuideo y Honor) dejaron de ser plataformas puras para volverse operadores. Pero Care.com y Nannapp cobran a la familia y siguen operando: el patrón no es una regla.
- **Los casos con pagador institucional crecieron:** Papa con aseguradoras, Careship con el seguro público alemán, Buurtzorg con el sistema de salud. ANA Care, el caso mexicano más cercano, terminó dependiendo de un tercero pagador.
- **La formalización laboral es el punto de quiebre económico.** HomeHero cerró ahí: al contratar a sus cuidadoras como empleadas, el costo de incorporarlas se multiplicó por diez. En México ese punto ya llegó por ley, con la afiliación obligatoria de las personas trabajadoras del hogar al IMSS [16].
- **Ninguno documenta con datos propios el problema que dice resolver.** En 7 de los 12 casos el problema nace de la experiencia de quien fundó la empresa o de una tesis comercial. Es la única ventaja real del Observatorio sobre sus referentes.

Caso	País	Quién paga	Qué enseña
HomeHero †	EUA	Familia	Levantó 23 millones de dólares y cerró en 2017; su ventaja dependía de no dar derechos laborales
Respect †	EUA	Familia	Cerró a los seis meses con unos 30 clientes: la app mejoró el servicio, no la contratación
Care.com	EUA	Familia	34 millones de usuarios y fallas graves de verificación: tracción no es seguridad
Nannapp	México	Familia	Nueve años operando en cuidado infantil; no es evidencia para personas mayores

Caso	País	Quién paga	Qué enseña
Gericare	México	Familia (probable)	Modelo de servicio gerontológico integral, no de emparejamiento
Cuideo	España	Familia	Creció al contratar cuidadoras propias, no por su algoritmo
Honor + Home Instead	EUA	Familia	La plataforma pura no escaló: compró una red física de franquicias
Papa Inc.	EUA	Aseguradoras y empleadores	Mide resultados (urgencias, reingresos), pero con evidencia propia y sin aleatorización
Careship	Alemania	Seguro público y familias	Cerca de la mitad de su demanda dependía de fondos públicos
Buurtzorg	Países Bajos	Sistema de salud	Único caso con evaluación externa, y su resultado es más modesto que su fama
ANA Care	México y 7 países	Agencias, aseguradoras, BID Lab	32 acreditaciones CONOCER contra una meta de 90; sin evaluación de impacto
Care Me	México	Desconocido	No se pudo verificar que opere: queda fuera de la argumentación

† Empresa cerrada. Fuentes: [44]–[55]; matriz de referencias del proyecto [58]. Consulta: 21 y 22 de septiembre de 2026.

> **LECTURA**
> Ningún caso de la matriz tiene una evaluación de impacto con asignación aleatoria. Estas referencias sirven para descartar modelos de negocio, no para prometer impacto.

SECCIÓN 14

Salarios y precios: cuatro rangos distintos

Hay cuatro rangos porque responden a cuatro decisiones distintas: lo que gana la persona cuidadora, lo que paga la familia, lo que cuesta operar el programa y lo que cuesta el equipo que sostiene el Observatorio. Confundirlos es el error más común en este tipo de documento.

Referencia salarial	Por hora	Naturaleza
Salario mínimo profesional de personas trabajadoras del hogar, 2026 ($342.47 al día)	$42.81	Piso legal aplicable
Mediana observada de cuidadoras en la ENASIC, ponderada y en pesos de 2026	$69.27	Lo que el mercado paga hoy; solo 26 casos
Tabulador CACEH 2026, categoría 8 ($904 al día)	$113.00	Referencia de trabajo digno; no es piso legal

Fuente: CONASAMI [17]; ENASIC 2022 [1]; CACEH [56] · script 04 [58].

El rango defendible para la remuneración de una persona cuidadora va de **$42.81 por hora**, piso legal no negociable, a **$113.00 por hora**, con un punto medio de trabajo de unos $77.90 para cuidado no especializado con formación certificada. Pagar por debajo del piso es ilegal. La mediana de $69.27 sale de muy pocos casos y se presenta como indicio, no como precio de mercado.

Paquete al piso legal	Costo al mes	Con IMSS e Infonavit	Pueden pagarlo, sin carga patronal	Pueden pagarlo, con IMSS e Infonavit
10 h por semana	$1,854	$2,261	40.0 %	35.5 %
20 h por semana	$3,707	$4,523	16.2 %	15.1 %
40 h por semana	$7,414	$9,046	5.3 %	3.5 %

«Pueden pagarlo»: hogares con necesidad cuyo ingreso permite cubrir el paquete sin rebasar el 20 % de su ingreso. Hogares del país, no de la CDMX. Fuente: ENASIC 2022 [1]; CONASAMI [17] · scripts 04 y 06 [58].

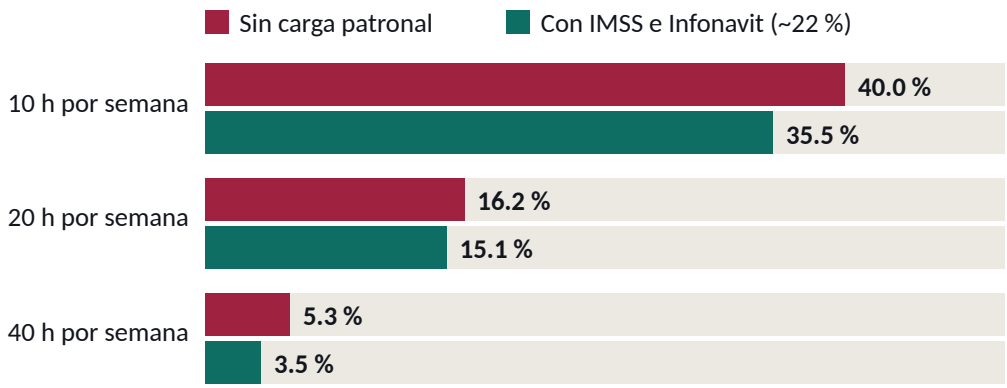


Figura 9. Hogares con necesidad que podrían pagar cada paquete al piso legal sin rebasar el 20 % de su ingreso (escala de 0 a 50 %). Nacional. Fuente: ENASIC 2022 · script 06 [58].

CORRECCIÓN · TABLA DE PAQUETES

La tabla equivalente del Documento Maestro mezclaba columnas: daba 35.5 % (con IMSS) para 10 horas, pero 16.2 % y 5.3 % (sin carga patronal) para 20 y 40 horas. El 3.5 % que citaba su texto para la jornada completa a precio de empleo formal era correcto.

La conclusión comercial es dura: **a precio de empleo formal, el pago directo alcanza al 3.5 % de los hogares con necesidad para jornada completa.** Ningún diseño de producto agranda ese número, porque depende del ingreso de los hogares y del costo legal del trabajo. Lo único que lo agranda es que alguien distinto de la familia pague una parte.

NIVEL DE EVIDENCIA · PROBABLE

El ingreso de los hogares es de 2022, llevado a 2026 con el índice de precios: es un supuesto, no un dato. La carga patronal de 22 % proviene de una calculadora de terceros y falta confirmarla con la calculadora oficial del IMSS.

El cuarto rango, la nómina del equipo del Observatorio, es el único que hoy no se puede anclar con una fuente verificada. Se declara el vacío en lugar de rellenarlo: el tabulador de la CDMX que se localizó corresponde a una administración anterior y no se usó. Las dos rutas para cerrarlo son el tabulador vigente, por solicitud de transparencia, o la ENOE por ocupación [5].

SECCIÓN 15

Escala del subsidio y modelo de sostenibilidad

La sección 10 mostró el escenario base. Aquí se agrega su versión con cuotas patronales, que es la que corresponde a empleo formal. En ambos casos el subsidio es el monto mensual por hogar que permitiría que el 25 % de los hogares con necesidad pagara media jornada al piso legal sin rebasar el 20 % de su ingreso.

Media jornada al piso legal, 25 % de los hogares	Sin carga patronal	Con IMSS e Infonavit
Subsidio mensual por hogar	$936	$1,752
Costo anual en la CDMX	3,089 millones	5,779 millones
Proporción del presupuesto local de cuidados solicitado para 2026	45.8 %	85.6 %
Costo anual nacional	43,465 millones	81,319 millones
Proporción del Anexo Transversal 31	9.3 %	17.4 %
Veces el presupuesto 2026 de la Secretaría de las Mujeres	20.3	38.0

Fuente: script 06 [58]; Anexo 31, PPEF 2026 [14]; Fundar [21]; solicitud de la CDMX (6,748 millones, prensa, por contrastar con el decreto aprobado).

A escala de ciudad, el subsidio parece imposible; a escala nacional, caro pero concebible. La conclusión es de diseño, no de resignación: el programa no puede plantearse como un subsidio general. Tiene que focalizarse en los hogares donde la falta de cuidado produce un costo verificable y evitable, porque solo ahí el subsidio se paga con el costo que evita.

15.1 Tres escenarios de pagador

Escenario	Quién paga	Veredicto
A · Pago directo de la familia	El hogar, íntegro	**Inviable** a salario formal: alcanza al 3.5 % de los hogares a jornada completa
B · Copago con pagador público	Hogar y Gobierno de la CDMX o federación	**Viable solo focalizado.** Recomendado para el piloto
C · Pagador por costo evitado	Aseguradora, empresa empleadora o sistema de salud	**Prometedor, sin evidencia propia.** Se mide dentro del piloto

Se recomienda el escenario B para el piloto y el C como hipótesis a medir dentro de él. Hay dos puertas institucionales. La Ley del Sistema Público de Cuidados de la CDMX, promulgada el 2 de julio de 2026 [18], [34], pide a la ciudad medir el trabajo de cuidados no remunerado: el Observatorio ofrece esa capacidad de medición, no una aplicación. Y el Anexo 31 incluye a CONOCER, con las personas cuidadoras como población objetivo, así que la certificación del perfil «Puedo cuidar» se conecta con un instrumento que ya existe.

> **LO QUE TODAVÍA NO ES**
>
> Esto no es un estudio de factibilidad financiera. Falta fijar el tamaño del piloto, el reparto del costo entre hogar y pagador, y la nómina del equipo; sin eso no se pueden calcular flujos, punto de equilibrio ni retorno. El indicador clave del escenario C se mide, no se promete: si un hogar que recibe horas de cuidado reduce la probabilidad de que la cuidadora principal deje su empleo.

SECCIÓN 16

Riesgos y supuestos del programa

Riesgo o supuesto	Qué pasa si falla
Supuesto central: la barrera es de confianza y norma familiar, no de precio	Todo el diseño cambia. Si fuera precio, bastaría un cupón

Riesgo o supuesto	Qué pasa si falla
Existirá una institución receptora para el piloto	No hay piloto, ni diagnóstico situado, ni medición de la barrera. Es el riesgo mayor y hoy no tiene responsable
Las tasas nacionales son aplicables a la CDMX	Cambia el dimensionamiento; la dirección del sesgo es conocida y subestima
La carga patronal es de 22 % y los presupuestos de referencia son los aprobados	Cambian los costos de las secciones 14 y 15; hoy son una calculadora de terceros y solicitudes reportadas en prensa
La certificación CONOCER puede absorber la demanda	La verificación se vuelve el cuello de botella, como en ANA Care (32 acreditaciones contra 90)
Riesgo ético: el programa capta datos de población vulnerable	Daño real a personas mayores, con discapacidad y cuidadoras. Exige protocolo de protección de datos antes del primer contacto

SECCIÓN 17

Indicadores y plan de validación

Los indicadores se organizan en tres bloques. Ninguno tiene todavía meta numérica, porque fijar metas sin línea base es un error que el equipo ya se señaló en un documento previo.

- **Social:** proporción de hogares atendidos en el quintil de ingreso más bajo; horas de cuidado no remunerado liberadas; permanencia en el empleo de la persona cuidadora principal.
- **Trabajo decente:** proporción de cuidadoras con pago igual o superior al piso legal e inscripción al IMSS; proporción con formación certificada.
- **Sostenibilidad:** costo total por hogar atendido y mes; proporción del costo que cubren el hogar, el pagador y el programa.

ANTES DE MEDIR EL PROGRAMA

El piloto debe medir primero el supuesto del que depende: preguntar a los hogares que ya pagan trabajo doméstico y no pagan cuidado, por qué. Si la respuesta dominante es precio, el programa se vuelve un mecanismo de subsidio. Si es confianza, un sistema de verificación y formación. Las dos respuestas son publicables; lo que no lo es, es no haber preguntado.

SECCIÓN 18

Pendientes y estado de la evidencia

18.1 Lo que falta decidir

- Confirmar o rechazar el reencuadre del 20 de septiembre a la luz del análisis por quintil: si el hallazgo central es precio o norma familiar. Responsables: Daniel y Alondra Danae.
- Adoptar o rechazar la propuesta de valor reformulada (secciones 8 y 9), que conserva los dos perfiles obligatorios pero cambia su función.
- Elegir el escenario de sostenibilidad como equipo: se recomienda B para el piloto y C como hipótesis a medir.
- Asignar responsables, con fecha límite, para conseguir la institución receptora del piloto y para anclar la nómina del Observatorio.
- Decidir si el interlocutor es solo el Gobierno de la CDMX o también el Sistema Nacional de Cuidados, y si se adopta el nombre de trabajo «Cuidar en casa».

18.2 Límites de la evidencia

- La ENASIC es nacional y tiene una sola edición: no sustenta conclusiones por alcaldía ni permite hablar de tendencias.
- Dos archivos CSV (población de 60 y más y capacidad residencial) no tienen productor ni año documentados.
- La oferta de cuidadoras es intención declarada, no oferta observada.
- No hay evidencia empírica mexicana sobre fraude de tutela por terceros: queda como pregunta abierta.
- **Doble revisión pendiente:** nada de este documento ha sido revisado todavía por Daniel ni por Alondra Danae.

FUENTES

Referencias

Datos estadísticos y plataformas

[1] INEGI. *Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022*: microdatos y presentación de resultados (25 feb 2025).

[2] INEGI. ENASIC 2022, boletín de resultados (comunicado 578/23): población enferma temporalmente que requirió cuidado.

[3] INEGI. *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)*, Ciudad de México, corte 05_2026.

[4] INEGI. *Censo de Población y Vivienda 2020*.

[5] INEGI. *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)*, microdatos trimestrales. Usada en la matriz de nichos (N7 · C1).

[6] INSP. *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT)*. Usada en la matriz de nichos (N5 · C1); no sustenta ninguna cifra de los hallazgos.

[7] Secretaría de Salud. Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Usado en la matriz de nichos (N5 · C4).

[8] Gobierno de la Ciudad de México. Portal de Datos Abiertos: población con discapacidad por AGEB. Usado en la matriz de nichos (N4 · C2).

[9] Secretaría de las Mujeres de la CDMX. Sistema de Indicadores de Género (SINGE), «Indicadores de cuidados». Origen probable de los CSV territoriales. https://indicadoresdegenero.semujeres.cdmx.gob.mx/indicadores/indicadores-de-cuidados **· añadida 25 sept 2026**

[10] Secretaría de las Mujeres. Plataforma de cuidados y Sistema de Información de Cuidados (SIDECU) (consulta 23 sept 2026). https://cuidados.mujeres.gob.mx/

[11] Secretaría de las Mujeres y DIF Nacional. «Presentan Secretaría de las Mujeres y DIF Nacional Sistema de Información de Cuidados (SIDECU)». https://www.gob.mx/mujeres/prensa/presentan-secretaria-de-las-mujeres-y-dif-nacional-sistema-de-informacion-de-cuidados-sidecu **· añadida 25 sept 2026**

[12] INMUJERES. Mapa de Cuidados (MACU). Sin revisar: no sustenta ninguna cifra todavía. https://mapadecuidados.inmujeres.gob.mx/ **· añadida 25 sept 2026**

[13] CONEVAL. Pobreza por grupos poblacionales a escala municipal 2010, 2015 y 2020 (consulta 22 sept 2026).

Normativa y documentos oficiales

[14] Gobierno de México. Anexo Transversal 31 del Sistema de Cuidados, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (consulta 23 sept 2026).

[15] Secretaría de las Mujeres. «El Paquete Económico 2026 contempla un inédito Anexo Transversal sobre cuidados; equivale al 1.21 % del PIB». https://www.gob.mx/mujeres/prensa/el-paquete-economico-2026-contempla-un-inedito-anexo-transversal-sobre-cuidados-equivale-al-1-21-del-pib **· añadida 25 sept 2026**

[16] Decreto de reforma a la Ley del Seguro Social en materia de personas trabajadoras del hogar. *Diario Oficial de la Federación*, 16 de noviembre de 2022.

[17] CONASAMI. Salarios mínimos profesionales 2026. *Diario Oficial de la Federación*, 9 de diciembre de 2025.

[18] Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, aprobada por el Congreso de la CDMX en mayo de 2026 y promulgada el 2 de julio de 2026 (según La Silla Rota, 2 jul 2026).

[19] Código Civil Federal, arts. 503–510 (personas inhábiles para desempeñar la tutela), vía Justia México.

[20] CIDH/OEA (2023). Comunicado sobre la reforma que garantiza el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad en México.

Análisis presupuestario

[21] Larios, A. (23 de septiembre de 2025). «Anexo 31 para la consolidación de un sistema de cuidados: avances y limitaciones». Fundar, Centro de Análisis e Investigación. https://fundar.org.mx/anexo-31-para-la-consolidacion-de-un-sistema-de-cuidados-avances-y-limitaciones/ **· añadida 25 sept 2026**

[22] CIEP (29 de octubre de 2025). «Sistema Nacional de Cuidados. Avances y limitaciones presupuestarias». https://ciep.mx/sistema-nacional-de-cuidados-avances-y-limitaciones-presupuestarias/ **· añadida 25 sept 2026**

Literatura académica e institucional

[23] Elson, D. (2017). «Recognize, Reduce, and Redistribute Unpaid Care Work: How to Close the Gender Gap». *New Labor Forum*, 26(2). https://doi.org/10.1177/1095796017700135 **· añadida 25 sept 2026**

[24] OIT (2018). *El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente*. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_737394.pdf **· añadida 25 sept 2026**

[25] OIT/Cinterfor. *La economía del cuidado: un pilar para el trabajo decente y la justicia social* (marco de las 5R).

[26] USC Keck School of Medicine. «Study: Financial abuse of older adults by family members more common than scams by strangers».

[27] Gutiérrez Juárez, L. A. et al. «La evolución de la interdicción en México como figura jurídica de vulneración a las personas con discapacidad». *Revista de Derecho Privado*, UNAM.

[28] «El estado de interdicción: la incapacidad de gobernarse a sí mismo». SciELO México.

[29] Lara Chagoyán, R. (2015). «Estado de interdicción, modelos». *Isonomía*, 42, 171–196.

Prensa

[30] Santiago, D. (15 de noviembre de 2024). «Se construirán 300 Centros de Desarrollo Infantil en la CDMX, anuncia Brugada». *Expansión Política*. https://politica.expansion.mx/cdmx/2024/11/15/se-construiran-300-centros-de-desarrollo-infantil-en-la-cdmx-anuncia-brugada **· añadida 25 sept 2026**

[31] «CDMX arranca el programa de Sistema Público de Cuidados con la primera Casa de las 3R» (21 de mayo de 2025). *El Financiero*. https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2025/05/21/cdmx-arranca-el-programa-de-sistema-publico-de-cuidados-con-la-primera-casa-de-las-3r/

[32] Navarrete, S. (25 de diciembre de 2025). «Casas de las 3R, Utopías y programas: ¿cómo funcionará el sistema de cuidados de la CDMX?». *Expansión Política*. https://politica.expansion.mx/cdmx/2025/12/25/casas-de-las-3r-utopias-y-programas-como-funcionara-el-sistema-de-cuidados-de-la-cdmx **· añadida 25 sept 2026**

[33] «CDMX destina 39.4 millones de pesos a personas cuidadoras de entre 18 y 56 años» (6 de junio de 2026). *El Heraldo de México*. https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2026/6/6/cdmx-destina-394-millones-de-pesos-personas-cuidadoras-de-entre-18-56-anos-826919.html **· añadida 25 sept 2026**

[34] «Brugada promulga la Ley de Cuidados en la CDMX; qué dice y a quién beneficia» (2 de julio de 2026). *La Silla Rota*. https://lasillarota.com/metropoli/2026/7/2/brugada-promulga-la-ley-de-cuidados-en-la-cdmx-que-dice-quien-beneficia-606754.html **· añadida 25 sept 2026**

[35] «Maltrato a adultos mayores en CDMX; Doña Say, uno de los 7,821 casos en 5 años» (11 de enero de 2024). *La Silla Rota*, con datos del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

[36] «Aumentan los fraudes digitales a adultos mayores en México: 21 % de casos es en línea» (18 de septiembre de 2026). *Infobae*.

[37] «Aguas con el Pensionazo: así funciona la estafa que roba dinero a personas adultas mayores» (18 de septiembre de 2026). *El Financiero*.

[38] «Más de 80,000 niños fantasma, entre las irregularidades de las estancias infantiles». *Forbes México*.

[39] «Gastos sin comprobar y más anomalías pusieron en la mira a estancias infantiles» (7 de febrero de 2019). *Expansión Política*.

[40] «CDMX elimina la tutela para personas adultas y adopta un modelo de toma de decisiones con apoyo». *YoTambién.mx*.

Documentos del proyecto

[41] Notebooks 01 (DENUE), 02 (territorio), 03 (ENASIC), 07 (necesidad frente a norma) y 09; scripts 04 (quintiles) y 06 (costos).

[42] Documento integrado v0.2 y v0.3; bitácora de decisiones del equipo.

[43] Riesgos_Cuidado_Fraude_Interdiccion_Informe_Completo.docx (25 de septiembre de 2026), informe de apoyo interno.

Referencias agregadas en las secciones 12 a 18

[44] *Home Health Care News* (febrero de 2017). Nota sobre el cierre de HomeHero. Consulta 21 sept 2026. https://homehealthcarenews.com/2017/02/homehero-ceases-operations-exits-home-care/ · **añadida 2 oct 2026**

[45] *Home Health Care News* (julio de 2017). Nota sobre el cierre de Respect. Consulta 21 sept 2026. https://homehealthcarenews.com/2017/07/another-tech-forward-home-care-startup-shuts-down/ · **añadida 2 oct 2026**

[46] Care.com: cobertura de la investigación de *The Wall Street Journal* (2019) sobre verificación de cuidadoras, vía *The Gazette* y Mintz Group. Consulta 21 sept 2026. https://mintzgroup.com/?p=2981 · **añadida 2 oct 2026**

[47] *Expansión* (11 de mayo de 2026), contenido patrocinado sobre Nannapp; y UnoTV. Consulta 21 sept 2026. https://expansion.mx/bespoke-ad/2026/05/11/nannapp-la-plataforma-de-cuidados-que-crece-bajo-la-mirada-de-su-creadora · **añadida 2 oct 2026**

[48] *Milenio*. Nota sobre Gericare. Consulta 21 sept 2026. https://www.milenio.com/negocios/por-una-cultura-gerontologica · **añadida 2 oct 2026**

[49] *Emprendedores* (España). Notas sobre el modelo de negocio de Cuideo. Consulta 21 sept 2026. https://emprendedores.es/casos-de-exito/cuideo-negocio-cuidados/ · **añadida 2 oct 2026**

[50] LeadingAge. Nota sobre la compra de Home Instead por Honor Technology (2021); y comunicados de Home Instead. Consulta 21 sept 2026. https://leadingage.org/honor-technology-acquires-home-instead/ · **añadida 2 oct 2026**

[51] Papa Inc.: estudios observacionales publicados como resúmenes de congreso (PMC9767256 y PMC9771416) y *Home Health Care News* (noviembre de 2022). Consulta 21 sept 2026. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9767256/ · **añadida 2 oct 2026**

[52] *TechCrunch* (24 de enero de 2017). Nota sobre el financiamiento de Careship; y CB Insights. Consulta 21 sept 2026. https://techcrunch.com/2017/01/24/berlins-careship-raises-4m-from-spark-capital-to-address-elderly-care/ · **añadida 2 oct 2026**

[53] The Commonwealth Fund (mayo de 2015). Estudio de caso sobre el modelo Buurtzorg en los Países Bajos. Consulta 21 sept 2026. https://www.commonwealthfund.org/publications/case-study/2015/may/home-care-self-governing-nursing-teams-netherlands-buurtzorg-model · **añadida 2 oct 2026**

[54] BID Lab. Memorando a los donantes ME-T1485/ME-G1023 (aprobado el 2 de mayo de 2022) y Reporte de Estado de Proyecto PSR-10479, 1 oct 2024 – 30 sept 2025, borrador (caso ANA Care). Consulta 22 sept 2026. https://www.iadb.org/es/proyecto/ME-T1485 · **añadida 2 oct 2026**

[55] *Emprendedores News*. Nota sobre Care Me. Fuente no reconsultada; el caso no sustenta ninguna afirmación. https://emprendedoresnews.com/emprendedores/care-me-la-startup-mexicana-uberizo-la-enfermeria.html · **añadida 2 oct 2026**

[56] CACEH. Tabulador de salarios 2026 para personas trabajadoras del hogar, categoría 8: cuidado de personas mayores o con discapacidad (abril de 2026). Verificado por el equipo el 22 sept 2026; referencia de sociedad civil, no piso legal. · **añadida 2 oct 2026**

[57] INMUJERES. Observatorio de Cuidados (OCU), catálogo de 374 indicadores. Fuente candidata, sin ficha. Consulta 25 sept 2026. https://observatoriodecuidados.inmujeres.gob.mx · **añadida 2 oct 2026**

[58] Documentos del proyecto: matriz de referencias (Analysis/matrices/matriz_referencias_matching.csv); scripts 04, 05 y 06 y notebook 09 con sus resultados en Analysis/resultados; Documento Maestro de avance (25 sept 2026). · **añadida 2 oct 2026**